

Épreuve de neurologie - neurochirurgie Session Janvier 2026

1. Une lésion de la région sellaire peut être suspecter devant:
 - A. Des signes d'hypersecrétion hormonale
 - B. Un syndrome alterne
 - C. Un syndrome cérébelleux
 - D. Des signes de compression du chiasma optique
 - E. Une aphasie
2. Les éléments cliniques orientant vers une suppuration intra crânienne sont :
 - A. La mise en évidence d'une porte d'entrée infectieuse
 - B. La présence de la triade de Bergman
 - C. La présence d'un syndrome infectieux
 - D. La présence d'un syndrome optochiasmatique
 - E. Les surinfections de plaies en post opératoires
3. Les localisations possibles de l'hydatidose rachidienne sont :
 - A. Intra médullaire
 - B. Intra durale et extra médullaire
 - C. Extra durale intra spinale
 - D. Vertébrale
 - E. Para vertébrale
4. Dans un syndrome de la queue de cheval on peut avoir :
 - A. Une amyotrophie des membres inferieurs.
 - B. un clonus rotulien.
 - C. Des troubles sphinctériens.
 - D. Une anesthésie en selle.
 - E. Un signe de Babinski .
5. La ou les causes d'un hématome intracérébral spontané est (sont) :
 - A. Une hypertension artérielle
 - B. Un athérome carotidien
 - C. Un maladie de système
 - D. Une prise d'anticoagulant
 - E. Une tumeur cérébrale
6. A propos du syndrome de la compression médullaire :
 - A. le diagnostic est basé essentiellement sur l'imagerie rachidienne.
 - B. Le méningiome est une cause intramédullaire.
 - C. l'IRM s'impose en urgence
 - D. Les troubles sphinctériens sont précoces
 - E. L'atteinte neurologique peut être réversible
7. Un patient âgé de 35 ans, admise au service de neurochirurgie pour une suspicion de rupture malformation artério - veineuse intracrânienne. Quel (s) examen (s) demanderiez-vous pour confirmer ce diagnostic ?
 - A. Une tomodensitométrie cérébrale sans injection de contraste.
 - B. Un EEG.
 - C. Une artériographie cérébrale.
 - D. Une ponction lombaire.
 - E. Des potentiels évoqués du tronc cérébral.

8. L'aggravation clinique d'un patient admis pour une rupture d'anévrisme intracrânien peut être due à:
- A. Une hydrocéphalie
 - B. Une démence
 - C. Un ressaignement
 - D. Une épilepsie
 - E. Un vasospasme artériel
9. Concernant les Spina Bifida :
- A. Les Spina bifida sont toujours symptomatiques
 - B. Elles découlent d'une malformation du tube neural au cours du troisième trimestre de la grossesse
 - C. Les myéломéningocèles sont de mauvais pronostic neurocognitif.
 - D. Le diagnostic positif anténatal repose sur l'échographie et l'IRM
 - E. Peuvent être accompagnées d'une malformation d'Arnold-Chiari
10. La Méningocèle se caractérise par les données suivantes:
- A. Les antiépileptiques sont une cause connue de la méningocèle
 - B. Une tuméfaction au niveau cervical est la plus fréquente
 - C. Le risque élevé de paraplégie et de troubles sphinctériens
 - D. Un risque élevé de retard mental
 - E. Le traitement préventif repose sur l'acide folique
11. Concernant les hydrocéphalies du nourrisson:
- A. La sténose de l'aqueduc de Sylvius est une cause fréquente
 - B. Un papillome du plexus choroïde est une étiologie par surproduction de LCR
 - C. Le regard en coude de soleil est un signe clinique de gravité
 - D. La dérivation ventriculo-péritonéale est le seul traitement efficace
 - E. L'échographie transfontanellaire permet de poser le diagnostic
12. Le tableau clinique de l'hydrocéphalie active de l'enfant en prépuberté est dominé par :
- A. Des céphalées en casque
 - B. Des fontanelles tendues
 - C. Des vomissements matinaux en jet
 - D. Un œdème papillaire au fond d'œil
 - E. Un syndrome démentiel
13. Le tableau clinique de l'hydrocéphalie active de l'enfant adolescent est dominé par :
- A. Une amnésie et des troubles de la marche
 - B. Des vomissements
 - C. Un syndrome pseudo-bulbaire
 - D. Une plagiocéphalie
 - E. Un œdème papillaire au fond d'œil
14. L'hydrocéphalie chronique de l'adulte âgé est caractérisée par :
- A. Des troubles de la mémoire
 - B. Des troubles de la marche
 - C. Une incontinence urinaire
 - D. Des vomissements en jet
 - E. Une amélioration clinique suite à une dérivation de LCR
15. Quel examen d'imagerie est considéré comme la référence pour confirmer le diagnostic de craniosténose et planifier l'intervention chirurgicale ?
- A. L'échographie simple
 - B. L'imagerie par résonance magnétique (IRM)
 - C. Le scanner (tomodensitométrie) avec reconstruction en trois dimensions (3D CT)
 - D. Une simple radiographie du crâne
 - E. Une scintigraphie osseuse

16. Un patient est admis en urgence pour un traumatisme crânien. Il émet quelques sons incompréhensibles, n'ouvre pas les yeux et réagit en décortication. Son score de glasgow est de :
- A. 3/15
 - B. 4/15
 - C. 5/15
 - D. 6/15
 - E. 7/15
17. Parmi les lésions traumatiques suivantes, la ou lesquelles nécessite(ent) un traitement chirurgical ?
- A. Un hématome du tronc cérébral
 - B. Un hématome de la région pinéale sans hydrocéphalie
 - C. Un hématome thalamique
 - D. Une fracture en regard du torcular
 - E. Une plaie craniocérébrale
18. Parmi les lésions traumatiques suivantes, la ou lesquelles nécessite(ent) un traitement chirurgical ?
- A. Une fracture ethmoïdale
 - B. Une fracture pédiculaire de C2
 - C. Un syndrome de Schneider en voie d'amélioration
 - D. Une fracture de C1 sans lésion ligamentaire
 - E. Une hernie discale cervicale traumatique avec déficit neurologique
19. Parmi les tumeurs suivantes, la ou lesquelles se développent surtout chez l'enfant ?
- A. Le méningiome
 - B. Le craniopharyngiome
 - C. Le schwannome vestibulaire
 - D. La métastase
 - E. Le médulloblastome
20. Parmi ces tumeurs, la ou lesquelles peuvent se transformer en tumeur maligne ?
- A. Le papillome du plexus choroïde
 - B. Le craniopharyngiome
 - C. L'astrocytome
 - D. L'adénome hypophysaire
 - E. L'ostéome frontal
21. Un méningiome intracrânien :
- A. Est toujours bénin
 - B. Est plus fréquent à l'étage sous tentoriel
 - C. Peut envahir les sinus duraux
 - D. Peut se révéler par une épilepsie
 - E. Nécessite souvent un traitement chirurgical
22. Un schwannome vestibulaire peut-être révélé par :
- A. Des acouphènes
 - B. Un torticolis
 - C. Une diplopie
 - D. Une paralysie faciale
 - E. Une hypoacousie
23. Un glioblastome
- A. Est une tumeur qui peut survenir aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte
 - B. Peut être multifocale
 - C. Peut envahir les commissures interhémisphériques
 - D. Nécessite une association chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie
 - E. Est une tumeur de bon pronostic

24. Quelles complications doit-on craindre chez un opéré du crâne ?

- A. Une hydrocéphalie aiguë
- B. Un hématome postopératoire
- C. Une méningite
- D. Une ischémie cérébrale
- E. Une ostéite du volet

25. Quelles complications doit-on craindre chez un opéré du rachis ?

- A. Une instabilité vertébrale
- B. Une épidurite
- C. Une ischémie médullaire
- D. Une fistule du LCR avec méningite
- E. Un hématome post opératoire

Patiente de 22 ans, qui présente depuis quelques jours, une faiblesse de l'hémicorps droit avec ataxie. L'interrogatoire note la présence de BAV il y a 6 mois ayant régressé en 3 jours. A l'examen vous retrouvez un syndrome hémipyrimalid droit, une dysarthrie cérébelleuse et un syndrome cérébelleux cinétique gauche.

26. Quelle topographie peut expliquer l'ensemble des symptômes du patient :

- A. Hémioelle cervicale gauche
- B. Hémibulbe gauche
- C. Mésencéphale gauche
- D. Multifocale
- E. Hémioelle cervicale droite

27. Le diagnostic le plus probable est :

- A. Neurobehçet
- B. AVC
- C. SEP
- D. Migraine
- E. Problème fonctionnel

28. Quel examen complémentaire faire en première intention :

- A. TDM cérébrale
- B. IRM encéphalique
- C. PL
- D. NFS/PQ
- E. Potentiels évoqués

29. Quel traitement offrir pour cette patiente ?

- A. Bolus de corticoïdes
- B. Traitement symptomatique
- C. Anti-inflammatoires
- D. Traitement de fond
- E. Se limiter à la surveillance

Patient âgé 66 ans, se plaint depuis 2 ans, de difficultés mnésiques, de troubles du comportement avec aphasie évoluant en marche d'escalier.

30. Le diagnostic le plus probable :

- A. Démence fronto-temporale
- B. Maladie d'Alzheimer
- C. Démence à corps de Lewy
- D. Démence vasculaire
- E. Confusion

31. Quels examens faire chez ce patient :

- A. EEG
- B. IRM encéphalique
- C. PL
- D. TPHA/VDRL, HIV
- E. ECG

32. Quelle prise en charge proposer au patient :

- A. Donépézil
- B. Dopamine
- C. Contrôle de l'HTA
- D. Aspirine
- E. Aucun traitement, juste des explications sur la maladie

Patiente de 7 ans, sans ATCDs pathologiques particuliers, présente de suspension du contact qui durent quelques secondes et se répètent plusieurs fois par jour impactant les résultats scolaires. L'examen et le développement psychomoteur sont normaux. Avec reprise immédiate de la conscience.

33. Les éléments en faveur d'une origine très probablement épileptique à ces phénomènes sont :

- A. Tableau syndromique connue
- B. La stéréotypie
- C. Le sexe
- D. L'âge
- E. L'absence d'ATCDs

34. Il s'agit de quel syndrome épileptique ?

- A. Absence
- B. Grand mal
- C. Épilepsie centro-rolandique
- D. Syndrome de West
- E. Épilepsie myoclonique juvénile

35. Que faut-il faire chez ce patient?

- A. Prendre la glycémie capillaire
- B. Imagerie
- C. EEG
- D. Ionogramme
- E. Démarrer un traitement de fond vu que c'est une épilepsie

Patient de 70 ans, se présente pour une IF hémicorps brutale droit depuis 4 heures Examen : syndrome hémipyrémidal droit à prédominance brachio-facial sans autres signes associés.

36. Les diagnostics les plus probables à évoquer ?

- A. AVC
- B. Thrombose veineuse profonde
- C. Hypoglycémie
- D. Démence sous corticale
- E. SEP

37. la topographie qui explique ce tableau :

- A. Capsule interne droite
- B. Capsule interne gauche
- C. Cortex cérébral gauche limitée
- D. Mésencéphale gauche
- E. Cortex cérébral gauche étendue

38. La CAT comprend :

- A. Envisager la thrombectomie
- B. Imagerie cérébrale
- C. Envisager la thrombolyse
- D. Aspirine si pas de cardiopathie à haut risque emboligène
- E. Kiné

39. Patient de 52 ans, présente depuis 6 mois des troubles psychiatriques à type de délire de mégalomanie et des troubles de mémoire. Examen clinique retrouve une atteinte extrapyramidale et syndrome démentiel. L'IRM encéphalique montre une atrophie corticale. Quel est le diagnostic à évoquer en premier chez ce patient?

- A. Encéphalite syphilitique
- B. Encéphalite auto-immune
- C. Maladie à prion
- D. Encéphalite sur déficit en Vitamine B1
- E. Aucune proposition

40. Chez ce patient, pour confirmer votre diagnostic, vous demanderiez quel examen paraclinique?

- A. Bilan immunologique
- B. Sérologie TPHA-VDRL dans le sang et le LCR
- C. Dosage de la vitamine B1
- D. Electroencéphalogramme
- E. Aucune proposition

41. La Sclérose Latérale Amyotrophique :

- A. Est la plus fréquente des maladies du motoneurone chez l'adulte.
- B. Les fasciculations sont liées à une hyperexcitabilité du motoneurone périphérique
- C. La médiane de survie de la maladie de Charcot est de 3 ans
- D. La forme brachiale débute par une amyotrophie de la main
- E. Aucune proposition

42. Quels sont les signes négatifs de la sclérose latérale amyotrophique :

- A. Absence de troubles sensitifs
- B. Absence de paralysie oculo-motrice
- C. Absence de troubles sphinctériens.
- D. Présence d'amyotrophie
- E. Aucune proposition

43. Patiente de 40 ans, sans antécédents particuliers, présente une chute de la paupière droite, parfois une vision double exacerbée en fin de journée. Examen clinique : ptosis droit, mobilité oculaire conservée, Reflexe photomoteur conservé. Quel est l'atteinte la plus probable chez cette patiente ?

- A. Jonction neuromusculaire
- B. Nerf moteur oculaire commun au niveau de l'orbite
- C. Musculaire
- D. Noyau de nerf moteur oculaire commun
- E. Nerf moteur oculaire commun au niveau du sinus caverneux

44. Le ou les examens paracliniques à demander chez cette patiente :

- A. Electroneuromyographie
- B. IRM encéphalique
- C. TDM thoracique
- D. Dosage de la créatine kinase
- E. Dosage des anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine

- 45. Patient âgé de 25 ans, présente suite à un syndrome grippal une impotence fonctionnelle des MI puis des MS installée sur 3 jours. Examen clinique retrouvait une tétraplégie, hypotonie des 4 membres, ROT abolis aux 4 membres, Reflexe cutanéoplantaire en flexion. Quel diagnostic évoqueriez vous en premier?**
- A. Myélite aiguë
 - B. Encéphalite aiguë
 - C. Polymyosite
 - D. Polyradiculonévrite aiguë
 - E. polyneuropathie
- 46. Quel bilan demanderiez vous chez ce patient?**
- A. Un scanner cérébral
 - B. Une IRM médullaire
 - C. Une électroneuromyographie
 - D. Une IRM musculaire
 - E. Etude du LCR
- 47. Étude du LCR montrait une protéinorachie à 0,9g /L, cellules à 2 éléments, quel(s)traitement (s) proposeriez vous ?**
- A. Corticoides
 - B. Immunoglobulines
 - C. Azathioprine
 - D. Plasmaphérèse
 - E. Interféron
- 48. Dans la neuropathie périphérique ; L'Electroneuromyographie:**
- A. Est une extension de l'examen clinique
 - B. Précise le type de la neuropathie (sensitive ou motrice)
 - C. Précise le mécanisme de la neuropathie (axonale ou démyélinisante)
 - D. Précise la sévérité de la neuropathie
 - E. Aucune proposition
- 49. La classification des neuropathies périphériques est basée sur :**
- A. Le mode d'installation et la durée des symptômes
 - B. Le type de fibres nerveuses
 - C. La topographie du déficit neurologique
 - D. Le mécanisme d'atteinte de la neuropathie périphérique
 - E. Aucune proposition
- 50. La myopathie de Duchenne :**
- A. Est la dystrophie musculaire la plus fréquente et la plus sévère chez l'enfant
 - B. La Créatine kinase est très élevée (plus de 10 fois la normale)
 - C. Les difficultés à la marche apparaissent vers 3 ans
 - D. Absence totale de dystrophine
 - E. Perte de la marche vers l'âge de 12 ans

Code candidat

Nom

Prénom

CORRECTION

Remarques

Université Cadi Ayyad
FMM - Marrakech
Année Universitaire 2025-2026
Session Janvier 2026
Path. Sys. Nerveux
4ème Année Médecine

09/02/26

14.00

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☐	☐	☒	☐
Q2	☒	☒	☒	☐	☒
Q3	☒	☒	☒	☒	☒
Q4	☒	☐	☒	☒	☐
Q5	☒	☐	☒	☒	☒
Q6	☐	☐	☒	☐	☒
Q7	☐	☐	☒	☐	☐
Q8	☒	☐	☒	☐	☒
Q9	☐	☐	☒	☒	☒
Q10	☒	☐	☐	☐	☒
Q11	☒	☒	☒	☐	☒
Q12	☒	☐	☒	☒	☐
Q13	☐	☒	☐	☐	☒
Q14	☒	☒	☒	☐	☒
Q15	☐	☐	☒	☐	☐
Q16	☐	☐	☐	☒	☐
Q17	☐	☐	☐	☐	☒
Q18	☐	☒	☐	☐	☒
Q19	☐	☒	☐	☐	☒
Q20	☐	☐	☒	☐	☐
Q21	☐	☐	☒	☒	☒
Q22	☒	☐	☐	☒	☒
Q23	☒	☒	☒	☒	☐
Q24	☒	☒	☒	☒	☒
Q25	☒	☒	☒	☒	☒

AB $\Rightarrow$ AD

C $\Rightarrow$ CE

D $\Rightarrow$ C

	A	B	C	D	E
Q26	☐	☐	☒	☐	☐
Q27	☐	☐	☒	☐	☐
Q28	☐	☒	☐	☐	☐
Q29	☒	☒	☐	☒	☐
Q30	☐	☐	☐	☒	☐
Q31	☒	☒	☒	☒	☒
Q32	☒	☐	☒	☒	☐
Q33	☒	☒	☒	☒	☐
Q34	☒	☐	☐	☐	☐
Q35	☐	☐	☒	☐	☒
Q36	☒	☒	☐	☐	☐
Q37	☐	☐	☒	☐	☐
Q38	☒	☒	☒	☒	☒
Q39	☒	☐	☐	☐	☐
Q40	☐	☒	☐	☐	☐
Q41	☒	☒	☒	☒	☐
Q42	☒	☒	☒	☐	☐
Q43	☒	☐	☐	☐	☐
Q44	☒	☐	☒	☐	☒
Q45	☐	☐	☐	☒	☐
Q46	☐	☐	☒	☐	☒
Q47	☐	☒	☐	☒	☐
Q48	☒	☒	☒	☒	☐
Q49	☒	☒	☒	☒	☐
Q50	☒	☒	☒	☒	☒

D $\Rightarrow$ C

E $\Rightarrow$ C